DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: ANGELICA MARIA VILLALOBOS RAMIREZ **Identificación** PT 5455240
Edad: 36 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS SA SUBSIDIADO 2025
Sala: QUIROFANO 5 **Fecha programación de cirugía:** 05/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**512104**	**COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**	Y41	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**540015**	**DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA LAPAROSCOPICA**	Y39	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**540102**	**LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**	Y40	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**541702**	**LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**	Y38	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**545101**	**LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**	Y40	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES183 CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

512104 **COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**
540015 **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA LAPAROSCOPICA**
540102 **LIBERACION DE PLASTRON EN ABDOMEN VIA LAPAROSCOPICA**
541702 **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**
545101 **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**

Dx Preoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Dx Postoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 05/11/26 **Fecha Final** 05/11/26
Hora Inicio 10:10:00 **Hora Final** 11:17:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:
BAJO ANESTESIA GENERAL, PREVIA SEPSIA Y ANTISPESIA,
SE COLOCACN CAMPOS ESTERILES, SE REALIZA INCISION TRASNUMBILICAL BAJO TECNICA HASON SE PASA PRIMER PURETO DE 10 MM
SE PASA SEGUNDO PEURTO BAJO VISION DIRECTA FLANCO DERECHO DE 5 MM
SE PASA TERCER PUERTO BAJO VISION DIRECTA SUBXIFOIDEO DE 10 MM
SE PASA CUARTO PEURTO BAJO VISION DIRECTA FLANCO DERECHO CON LAm DE 5 MM

SE EVIDENCIA:
PLASTRON VESIUCLAR VESIUCLAR MUY INFLAMADA, CON EPIPLON MAYOR, ESTOMAGO
ADHRENCIAS QUE RETRAEN EL HIGADO A LA PARED ABDOMINAL
VESICULA BILIARDE PAREDES ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS DE GRAN TAMAÑO Y ABUNDANTE BILIS DE EXTASIS.
LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCALR 300 ML APROX
CISTICO CORTO Y DELGADO
VIA BIALIR PRINCIPAL DECRACTERISTICAS NORMALES

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

ARTERIA CISTICA DE GRAN CALIBRE Y ANTERIOR
VASO ACCESORIO POSTERIOR D EGRAN CALIBRE
LECHO VESIUCLAR EDEMATIZADO Y CRUENTO
SE PROCEDE ACON DISECCION Y LEVANTAMEINTO DE ADHRENCIAS A HIGADO Y A ESTOMAGO
SE REALIZA DISECCION ROMA Y CON HIDRODISECCION DE PLASTRON VESIUCLAR
SE EVACUA LIQUIDO INFLAMATOIO DE 300 ML LIBRE EN CAVIDAD ABDOMINAL, SE PROCEDEE A DRENAJE DE VESIUCAL
BIOÑLAIR PARA FACILITAR SU MANIPULÑACION.
CAUTERIZACION DE EPIPLON EDEMATIZADO .
SE IDENTIFICACION LABORIOSA DE TRINGULO DE CALOT, SE TIENE VISION DE SEGURIDAD
SE REALIZA PINZAMEINTO CON CLIPS DE 300 SOBRE ARTERIA CISTICALA CUAL ESTA AUMENTADA DE TAMAÑO PROMEDIO SE
CLIPA CON 2 CLIPS Y AL IGUAL A VASO POSTERIOR
SE REALIZA PÍNZAMEINTO CON CLIPS 300 SOBRE CONDUCTO CISTICO SE REALIZA CLIPADO CON 5 CLIPS MUYY CERCA A
LA REAIZ DEL CISTICO CON EL CONDUCTO HEPATICO COMUN,
SE REALIZA COLECISTECTOMIA CISTOFUNDICA
LECHO VESIUCLAR CRUENTO Y DE SANGRADO FACIL
PUERTOS LAPAROSCOPICOS DE SANGRADO FACIL
SE REALIZA HEMOSTASIA DE LECHO VESIUCALR
SE PROCEDE A LAVADO DE CAVIDAD ABDOMNINAL CON 1500 ML DE LIQUIDOS
Y SE EXTRAEN CUAGULOS
SE RETIRA VESIUCAL
SE TIENE CONTEO DE MATERIAL COMPLETO
SE RETIRAN PUERTOS Y NEUROMPERITONEO
SINTESIS D EPUERTOS CON VYCRIL 1
PIEL Y TCS CONPROLENE 3.0
FIN DE ACTO QUIURURGICO

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

PLASTRON VESIUCLAR VESIUCLAR MUY INFLAMADA, CON EPIPLON MAYOR, ESTOMAGO
ADHRENCIAS QUE RETRAEN EL HIGADO A LA PARED ABDOMINAL
VESICULA BILIARDE PAREDES ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS DE GRAN TAMAÑO Y ABUNDANTE
BILIS DE EXTASIS.
LIQUIDO INFLAMATOIO PERIVESIUCALR 300 ML APROX
CISTICO CORTO Y DELGADO
VIA BIALIR PRINCIPAL DECRACTERISTICAS NORMALES
ARTERIA CISTICA DE GRAN CALIBRE Y ANTERIOR
VASO ACCESORIO POSTERIOR D EGRAN CALIBRE
LECHO VESIUCLAR EDEMATIZADO Y CRUENTO

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

VESICULA BILIAR

Carlos I Forero
CARLOS IVAN FORERO R. CIRUGIA GENERAL R.M. 76-0629

CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ
Reg. 760629
CIRUGIA GENERAL

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***